

SOAL UJIAN OSCE STATION ANESTESIA OBSTETRIK

1	Nomor Station	1B
2	Judul station	Anestesia obstetrik – sectio caesarea dengan spinal anestesia dan manajemen penyulit appendicitis akut.
3	Waktu yang dibutuhkan	17 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta melakukan rencana tindakan anestesi, keterampilan klinis, monitoring dan manajemen penyulit serta komunikasi, edukasi dan profesionalisme.
5	Kompetensi	1. Evaluasi pra anestesia 2. Diagnosis dan problem aktual – potensial 3. Rencana tindakan anestesi 4. Keterampilan klinis 5. Monitoring dan manajemen penyulit 6. Manajemen pasca anestesia 7. Komunikasi, edukasi dan profesionalisme
6	Kategori	1. Anestesia Obstetrik 2. Anestesia Bedah Saraf 3. Anestesia Regional Dan Manajemen Nyeri 4. Anestesia Bedah Toraks 5. Anestesia Pediatrik 6. Anestesia Kegawatdaruratan 7. Anestesia Urologi 8. Anestesia Untuk Penyakit Khusus (Endokrin) 9. Anestesia Bedah Kepala Leher 10. Anestesia Bedah Rawat Jalan / Luar Kamar Bedah 11. Anestesia Pada Prosedur Invasif Minimal 12. Terapi Intensif
7	Instruksi untuk peserta	<u>Skenario Klinik :</u> Seorang perempuan berusia 28 tahun berat badan 75 kg dengan G1P0A0 kehamilan aterm inpartu, letak sungsang, disertai appendicitis akut dengan Tekanan Darah 138/88 mmHg laju nadi 112 x/menit, laju napas 18x/mnt, suhu: 39,2 °C. Pasien akan dilakukan operasi SC cito dan appendiktomi, dengan anestesi spinal. <u>Instruksi Peserta:</u> 1. Sebutkan problem potensial dan aktual pada pasien ini! 2. Sebutkan persiapan pasien sebelum tindakan Anestesi! 3. Lakukan anestesi spinal pada pasien ini! 4. Sebutkan manajemen nyeri pasca anestesi spinal pada pasien ini!
8	Instruksi untuk penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian pada kartu ujian. 2. Tulislah nama dan nomor peserta ujian pada lembar penilaian. 3. Amatilah dan berilah skor (0/1/2/3) atas tugas yang dikerjakan peserta ujian serta skor <i>Global Rating</i> sesuai rubrik penilaian. 4. Hindarilah interupsi dan/atau tindakan selain daripada yang

		diminta dalam instruksi penguji. 5. Berikan informasi/hasil yang dibutuhkan secara lisan/tulisan hanya apabila peserta ujian telah melakukan dan/atau mengusulkan jenis pemeriksaan yang dimaksud (perhatikan instruksi khusus). 6. Pada station ini akan digunakan mesin monitor pasien dinamis yang akan dikendalikan oleh penguji sesuai setting yang akan ditentukan pada instruksi khusus penguji 7. Taatilah peraturan serta etika penguji selama menjalankan tugas sebagai penguji OSCE – ATI. INSTRUKSI KHUSUS 1. Penguji menilai peserta menyebutkan problem aktual dan potensial pada pasien ini. Problem aktual: 1. Kehamilan 2. hipertermia 3. nyeri akut Problem potensial: 4. Mual muntah 5. aspirasi 6. hipotensi 7. bradikardia 8. high spinal block 2. Penguji menilai peserta menyebutkan persiapan pasien sebelum tindakan Spinal anestesi yang dikerjakan peserta ujian. 1. Pasang IV line nomor besar dan lancar 2. Rehidrasi dengan cairan kristaloid 3. Puasa atau nothing per oral 4. Turunkan suhu tubuh 5. Pemberian obat anti muntah 6. Pemberian antibiotic 3. Penguji menilai pelaksanaan tindakan Spinal anestesi yang dikerjakan peserta ujian. SPINAL ANESTESI : 1. Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital sebelum 2. Memposisikan pasien lateral decubitus kiri atau duduk 3. Membuat landmark yaitu L3-L4 sejajar dengan aspektus superior krista iliaka (<i>Tuffier's line</i>) dan menentukan titik penusukan. 4. Cuci tangan dan memakai gaun bedah steril, memakai sarung tangan steril. 5. Melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada landmark
--	--	--

		yang sudah ditentukan dan menutupnya dengan doek lobang steril. 6. Melakukan infiltrasi anestesi lokal pada celah yang akan dilakukan penusukan jarum spinal. 7. Melakukan penusukan jarum spinal sampai keluar LCS 8. Memasukkan obat anestesi lokal secara perlahan. 9. Memastikan blok spinal berjalan baik, target blok yang adekuat untuk sc adalah dari Th 4 -6. 4. Penguji menilai manajemen nyeri pasca anestesi spinal pada pasien ini: • Multimodal analgesi - NSAID - Opioid - Paracetamol	
9	Tata letak station	Setting kamar operasi	
10	Kebutuhan Laboran	1 orang sebagai penata (asisten) anestesi	
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan kamar operasi - Spinal set - Nampan alat - Duk lobang - Cawan 3 dengan label povidone iodine, alkohol, nacl 0,9% - Korentang - Kassa - Spinocain no 25, 26,27 - Topi dan Masker - Sarung tangan steril 6,5 7 7,5 - Alkohol 70% - Povidone iodine 10% - S spuit 1 cc, 3 cc, 5 cc, 10 cc - Plester - Gunting - Obat anestesi lokal (lidocaine, bupivacaine, ropivacaine) - Obat ephedrine + S spuit dengan label ephedrine - Water for injection	3 set 1 buah 1 buah 1 set 1 buah 5 buah @ 5 buah 1 kotak @10 buah 1 botol 1 botol 2 set 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah
12	Kebutuhan manekin	Manekin Spinal	
12	Penulis	Tim Soal OSCE ATI	
13	Referensi	Morgan & Mikhail's Clinical Anesthesiology 5 th Edition	

**RUBRIK ACTUAL MARK
OSCE STATION ANESTESIA OBSTETRIK**

Aspek yang Dinilai	0	1	2	3	Bobot	Skor
1. Diagnosis dan problem aktual – potensial Problem aktual: 1. Kehamilan 2. hipertermia 3. nyeri akut Problem potensial: 4. Mual muntah 5. aspirasi 6. hipotensi 7. bradikardia 8. high spinal block	Peserta tidak menyebutkan problem aktual dan potensial	-	Peserta menyebutkan problem aktual dan potensial kurang dari 5	Peserta menyebutkan problem aktual dan potensial lebih dari 5	2	
3. Rencana tindakan anestesi. 1. Pasang IV line 2. Rehidrasi cairan 3. Puasa 4. Turunkan suhu tubuh 5. Pemberian obat anti muntah 6. Pemberian antibiotik	Peserta tidak menyebutkan persiapan	-	Peserta menyebutkan persiapan kurang dari 3	Peserta menyebutkan persiapan lebih dari 3	1	
4. Keterampilan klinis SPINAL ANESTESI : 1. Melakukan pemasangan monitor standar dan mengamati tanda vital	Peserta ujian tidak melakukan tindakan spinal anesthesia	Peserta ujian melakukan tahapan tindakan Spinal	Peserta ujian melakukan tahapan tindakan Spinal anesthesia	Peserta ujian melakukan tahapan tindakan Spinal anesthesia dengan	3	

sebelum tindakan - Memposisikan pasien lateral decubitus kiri atau duduk - Membuat landmark yaitu L3-L4 sejajar dengan aspektus superior krista iliaka (<i>Tuffier's line</i>) dan menentukan titik penusukan. - Cuci tangan dan memakai gaun bedah steril, memakai sarung tangan steril. - Melakukan tindakan aseptik dan antiseptik pada landmark yang sudah ditentukan dan menutupnya dengan doek lobang steril. - Melakukan infiltrasi anestesi lokal pada celah yang akan dilakukan penusukan jarum spinal. - Melakukan penusukan jarum spinal sampai keluar LCS - Memasukkan obat anestesi lokal secara perlahan. - Memastikan blok spinal berjalan baik, target blok yang adekuat untuk sc adalah dari Th 4 -6.		anestesia dengan tidak lengkap dan tidak berurutan serta gagal/tidak keluar cairan LCS	dengan tidak lengkap dan tidak berurutan tapi berhasil keluar cairan LCS	benar, lengkap dan berurutan serta berhasil keluar cairan LCS		
5. Manajemen nyeri pasca anestesi spinal pada pasien ini: - Multimodal analgesi - NSAID - Opioid - Paracetamol	Peserta tidak menyebutkan manajemen nyeri	Peserta menyebutkan 1	-	Peserta menyebutkan lebih dari 1	3	

7. Komunikasi dan Perilaku profesional 1. melakukan setiap tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga tidak membahayakan pasien dan diri sendiri 2. memperhatikan kenyamanan pasien 3. melakukan tindakan sesuai prioritas 4. menunjukkan rasa hormat kepada pasien 5. mengetahui keterbatasan dengan merujuk atau melakukan konsultasi bila diperlukan	Peserta tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali tidak melakukan poin Komunikasi dan Perilaku professional.	Peserta meminta izin secara lisan dan melakukan 1-2 poin perilaku profesionalisme.	Peserta meminta izin secara lisan dan melakukan 3-4 point perilaku profesionalisme.	Peserta melakukan secara lengkap perilaku profesionalisme.	1	
TOTAL SKOR						